

Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)

1. Introducción y relevancia clínica

La **Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)**, actualmente denominada **Púrpura Trombocitopénica Inmune**, es una enfermedad autoinmune adquirida caracterizada por una **disminución aislada del recuento plaquetario ($<100.000/\mu\text{L}$)** debido a la **destrucción acelerada de plaquetas mediada por anticuerpos**, sin evidencia de otras causas hematológicas, infecciosas o medicamentosas.

En Chile, la incidencia estimada es de **3 a 4 casos por 100.000 habitantes por año**, afectando principalmente a **mujeres jóvenes** y a **niños tras infecciones virales**.

En adultos, la PTI tiende a ser **crónica y recidivante**, mientras que en niños suele ser **aguda y autolimitada**.

La importancia clínica radica en el **riesgo de hemorragias potencialmente graves**, especialmente cuando las plaquetas caen bajo $20.000/\mu\text{L}$.

En el **EUNACOM**, este tema es frecuente porque ilustra la **fisiopatología autoinmune**, el **enfoque diagnóstico de trombocitopenia** y el manejo de primera línea con **corticoides e inmunoglobulina IV**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La PTI es una **enfermedad autoinmune** donde el sistema inmunológico produce **anticuerpos IgG dirigidos contra antígenos de membrana plaquetaria**, principalmente **GP IIb/IIIa** y **GP Ib/IX**.

Estos complejos inmunes se fijan al receptor Fc de los macrófagos del **bazo y del sistema reticuloendotelial**, provocando **fagocitosis y destrucción de plaquetas**.

Mecanismos fisiopatológicos principales:

1. Destrucción periférica aumentada:

Los anticuerpos opsonizan las plaquetas, que luego son eliminadas por macrófagos esplénicos.

Este mecanismo explica la respuesta favorable a la esplenectomía.

2. Producción ineficaz:

Los autoanticuerpos también afectan a los **megacariocitos medulares**, reduciendo la formación de nuevas plaquetas.

3. Alteración de la inmunorregulación:

Existe un **desequilibrio entre linfocitos T reguladores (Treg) y linfocitos T efectores**, junto con activación anormal de linfocitos B productores de autoanticuerpos.

4. Asociaciones y gatillantes:

- Infecciones virales (EBV, CMV, VIH, H. pylori, hepatitis C).
- Enfermedades autoinmunes (LES, síndrome antifosfolípido).
- Fármacos (quinina, heparina, sulfamidas, rifampicina).

En resumen:

La PTI combina **destrucción inmune acelerada** y **disminución de la producción plaquetaria**, lo que explica su curso variable y respuesta terapéutica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Presentación clínica típica

La PTI se caracteriza por **sangrado cutáneo-mucoso**, con ausencia de alteraciones hematológicas o visceromegalias.

Manifestaciones frecuentes:

- **Petequias y equimosis** en extremidades inferiores.
- **Epistaxis, gingivorragia, menorragia.**
- **Hematuria o rectorragia** (en casos severos).
- **Sangrado intracraneal:** poco común (<1%), pero potencialmente fatal.

Síntomas constitucionales: habitualmente ausentes.

Esplenomegalia: rara; su presencia obliga a considerar otra causa de trombocitopenia.

En niños:

La PTI aparece 1–3 semanas tras una infección viral o vacunación.

Cursa de forma aguda y se resuelve espontáneamente en 80% de los casos.

En adultos:

Evolución crónica (>12 meses), con recaídas o necesidad de tratamiento prolongado.

3.2. Diagnóstico diferencial

Es fundamental distinguir la PTI de otras causas de trombocitopenia, ya que el tratamiento y pronóstico difieren.

Principales diagnósticos diferenciales:

- **Pseudotrombocitopenia:** artefactual (plaquetas agregadas en EDTA).
- **Trombocitopenia inducida por fármacos:** heparina, antibióticos, anticonvulsivantes.
- **Trombocitopenia por sepsis o CID.**
- **Síndrome mielodisplásico o aplasia medular.**
- **Trombocitopenia por VIH, hepatitis C o EBV.**
- **LES o síndrome antifosfolípido.**
- **Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT):** cursa con anemia hemolítica microangiopática, fiebre y compromiso neurológico.

En EUNACOM: siempre recordar que una **trombocitopenia aislada sin anemia ni leucopenia** sugiere PTI.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La PTI es un **diagnóstico de exclusión**.

No existe una prueba específica, pero hay exámenes que apoyan el diagnóstico y descartan otras causas.

4.1. Exámenes básicos

- **Hemograma:** trombocitopenia aislada ($<100.000/\mu\text{L}$), con hematocrito y leucocitos normales.
- **Frotis de sangre periférica:** plaquetas de tamaño normal o grande (“plaquetas jóvenes”), sin esquistocitos.
- **Tiempos de coagulación (TP, TTPa):** normales (distingue PTI de CID o coagulopatías).
- **Pruebas hepáticas y renales:** normales.

4.2. Exámenes de extensión

- **Serología VIH y VHC:** deben solicitarse en todos los pacientes adultos con trombocitopenia.
- **Helicobacter pylori:** la infección se asocia a PTI refractaria; su erradicación mejora recuentos plaquetarios.
- **Anticuerpos antinucleares (ANA) y antifosfolípidos:** si hay sospecha de enfermedad autoinmune.
- **Mielograma:** indicado solo si edad >60 años, refractariedad o sospecha de otra enfermedad hematológica.

Diagnóstico de PTI:

- Trombocitopenia aislada persistente $<100.000/\mu\text{L}$.
- Ausencia de anemia, leucopenia, esplenomegalia o alteraciones en coagulación.
- Exclusión de causas secundarias (infecciosas, farmacológicas, autoinmunes o neoplásicas).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y ASH 2023)

El objetivo terapéutico **no es normalizar las plaquetas**, sino **prevenir hemorragias graves**, manteniendo recuentos $>30.000\text{--}50.000/\mu\text{L}$.

La conducta depende de la severidad, la edad y el riesgo hemorrágico.

5.1. En niños

- La mayoría son autolimitados → **observación** si plaquetas $>20.000/\mu\text{L}$ y sin sangrado.
 - En casos de sangrado mucoso significativo o plaquetas $<20.000/\mu\text{L}$:
 - **Prednisona oral:** 1–2 mg/kg/día por 1–2 semanas, luego descenso progresivo.
 - **Inmunoglobulina IV (IGIV):** 1 g/kg por 1–2 días (respuesta rápida).
 - **Anti-D inmunoglobulina:** alternativa en Rh+ no esplenectomizados.
-

5.2. En adultos

A. Tratamiento de primera línea:

1. Corticoides sistémicos:

- Prednisona 1 mg/kg/día (máx. 80 mg/día) por 2–4 semanas, luego taper gradual.
- Alternativa: dexametasona 40 mg/día por 4 días.
- Eficacia: 60–80%, pero recaídas frecuentes al suspender.

2. Inmunoglobulina IV (IGIV):

- 1 g/kg/día por 2 días, indicada en sangrado activo o cirugía urgente.
- Efecto transitorio (aumento de plaquetas en 24–48 h).

3. Erradicación de *Helicobacter pylori*:

- Terapia triple (IBP + claritromicina + amoxicilina) mejora respuesta en hasta 30% de casos refractarios.
-

B. Tratamiento de segunda línea:

Indicada en **PTI crónica (>12 meses)** o refractaria a corticoides.

1. **Esplenectomía:**

- Remueve el principal sitio de destrucción plaquetaria.
- Eficacia: remisión sostenida en 60–70% de los casos.
- Complicaciones: sepsis por gérmenes encapsulados (neumococo, meningococo).
- Requiere vacunación previa y profilaxis antibiótica.

2. **Agonistas del receptor de trombopoyetina (TPO-RA):**

- Romiplostim (subcutáneo semanal) o eltrombopag (oral diario).
- Estimulan producción plaquetaria medular.
- Útiles en PTI crónica o refractaria.

3. **Rituximab (anti-CD20):**

- Indicado en pacientes jóvenes o con recaídas tempranas.
- Eficacia: remisión prolongada en 40–50%.

C. Tratamiento de rescate o refractario:

- Azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida o danazol.
- Nuevos fármacos (fostamatinib) en casos resistentes.
- Transfusión plaquetaria solo si sangrado activo o antes de cirugía; su efecto es temporal.

5.3. Conducta en urgencias

- Si hemorragia severa o intracraneal:
 - IGIV + corticoides IV + transfusión plaquetaria.
 - Hospitalización y monitoreo intensivo.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones principales:

- **Hemorragia intracraneal:** la más temida, aunque poco frecuente.
- **Hemorragias digestivas o genitourinarias severas.**
- **Infecciones graves post-esplenectomía.**
- **Osteoporosis y síndrome de Cushing por uso prolongado de corticoides.**

Pronóstico:

- En niños: recuperación completa en 80–90% de los casos.
- En adultos: curso crónico en 60–70%, pero la mortalidad es baja (<1%).
- La mayoría logra control adecuado con manejo médico.
- Recaídas pueden presentarse durante infecciones o suspender tratamiento inmunosupresor.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **PTI se caracteriza por trombocitopenia aislada**, con hemograma y coagulación normales.
2. El **frotis sin esquistocitos** descarta microangiopatía.
3. La **ausencia de esplenomegalia** ayuda a diferenciarla de otras causas.
4. El tratamiento inicial son **corticoides e inmunoglobulina IV**.
5. En PTI crónica, considerar **esplenectomía o agonistas TPO**.
6. La **erradicación de H. pylori** puede mejorar el recuento plaquetario.

7. En EUNACOM, suele presentarse mujer joven con equimosis y plaquetas <50.000 , con hemograma normal.

Errores comunes:

- Administrar transfusión plaquetaria sin sangrado activo.
 - No descartar causas secundarias (VIH, hepatitis C).
 - No vacunar antes de esplenectomía.
 - Mantener corticoides prolongadamente sin taper.
 - Confundir con púrpura trombótica trombocitopénica (PTT).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **PTI es una trombocitopenia autoinmune** con destrucción acelerada de plaquetas.
2. Se presenta con **sangrado cutáneo-mucoso y sin alteraciones en hemoglobina o leucocitos**.
3. El diagnóstico es **de exclusión**; hemograma y coagulación son normales.
4. El tratamiento inicial incluye **corticoides e inmunoglobulina IV**.
5. En casos crónicos o refractarios, considerar **esplenectomía o agonistas del receptor TPO**.
6. Es fundamental **vacunar previo a esplenectomía** y prevenir infecciones.
7. En EUNACOM, se evalúa el enfoque diagnóstico y manejo escalonado.